



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN KERJA
TIM GERIATRI
2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada

Nomor : 575.7/I-PDM/DIR/VI/2025

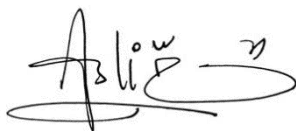
Tentang
Pedoman Kerja Tim Geriatri

Disusun oleh :
Ketua Tim Geriatri



(dr. Heriyatmo, Sp.PD)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman TIM GERIATRI Rumah Sakit Prima Husada dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Prima Husada. Pedoman Kerja TIM GERIATRI ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga. Semoga dengan dipergunakan Pedoman Kerja TIM GERIATRI ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 09 Juni 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN
PEDOMAN KERJA TIM GERIATRI

Pengarah & Editor : Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP.,CCHt.,CI.,CHAE.,CHQP

Penyusun:

1. dr. Resti Lestantini, M. Kes
2. dr. Heriyatmo, SpPD
3. dr. Amanda Firmandani
4. Ns. Isa Ariyanti, S.Kep
5. Ns. Risma Indra Setiyani, S. Kep
6. Ns. Artika Wulandari S. Kep

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
TIM PENYUSUN	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Sasaran	2
BAB II	
2.1 TATA LAKSANA	3
BAB III Organisasi Tim Geriatri	4
3.1 Pimpinan dan Staf	4
3.2 Sarana dan Fasilitas Penunjang	5
BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	6
4.1 Moniting	7
4.2 Evaluasi dan Pelaporan	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. Alur Pelayanan di Rumah Sakit dengan Pelayanan Geriatri Tingkat Paripurna
11

Gambar 3.1 Bagan Tim terpadu Geriatri 12



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
Nomor : 575.7/I-PDM/DIR/VI/2025

TENTANG
PEDOMAN KERJA TIM GERIATRI

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. Bahwa terjadi peningkatan populasi lanjut usia di Indonesia yang dapat menimbulkan permasalahan terkait aspek medis, psikologis, ekonomi, dan sosial sehingga diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan terhadap warga lanjut usia;
- b. Bahwa Rumah sakit mempunyai Komite/Tim atau bentuk organisasilainnya yang kompeten untuk mengelola kegiatan Pelayanan Geriatri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu penetapan Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Tim Geriatri Rumah Sakit
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 229/Menkes/SK/VII/2012 tentang Pedoman Pelayanan Psikogeriatric.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit.
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;.
10. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN KERJA TIM GERIATRI

Pasal 1



Rumah sakit menyediakan pelayanan geriatri rawat jalan, rawat inap akut dan rawat inap kronis sesuai dengan tingkat jenis pelayanan.

Pasal 2

Rumah Sakit melakukan promosi dan edukasi sebagai bagian dari Pelayanan Kesehatan Warga Lanjut usia di Masyarakat Berbasis Rumah Sakit (Hospital Based Community Geriatric Service).

Pasal 3

Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan geriatri sesuai dengan tingkat jenis pelayanan geriatri tingkat lengkap

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Direktur ini dilakukan oleh Tim Geriatri sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 5

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal 09 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR : 575.7/I-PDM/DIR/VI/2025
TENTANG PEDOMAN KERJA GERIATRI

PEDOMAN KERJA TIM GERIATRI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhatian pemerintah terhadap keberadaan lanjut usia ini cukup besar, yang diawali pada tahun 1996 dengan ditetapkannya tanggal 29 Mei yang diperingati setiap tahun sebagai Hari Lanjut Usia. Selanjutnya pada tahun 1998, perhatian ini diperkuat dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai landasan hukum keberadaan para lanjut usia. Di bidang kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia ditujukan untuk menjaga agar para lanjut usia tetap sehat, mandiri, aktif dan produktif secara sosial dan ekonomi sehingga untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi pengembangan kelompok lanjut usia. Makin bertambah usia, makin besar kemungkinan seseorang mengalami permasalahan fisik, jiwa, spiritual, ekonomi dan sosial. Salah satu permasalahan yang sangat mendasar pada lanjut usia adalah masalah kesehatan akibat proses degeneratif, hal ini ditunjukkan oleh data pola penyakit pada lanjut usia. Berdasarkan riset kesehatan dasar (riskesdas) tahun 2013, penyakit terbanyak pada lanjut usia terutama adalah penyakit tidak menular antara lain hipertensi, osteo arthritis, masalah gigi-mulut, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) dan Diabetes Mellitus (DM). Masalah utama bagi para lanjut usia adalah pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, oleh karena itu perlu dikembangkan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan upaya peningkatan, pencegahan, dan pemeliharaan kesehatan di samping upaya penyembuhan dan pemulihan.

Melalui pembinaan kesehatan dengan pendekatan siklus hidup yang dimulai sejak dari seorang ibu mempersiapkan kehamilannya, sampai bayinya lahir dan berkembang menjadi anak, remaja, dewasa, dan pra lanjut usia, akan sangat menentukan kualitas kehidupan dan kesehatan di saat memasuki masa lanjut usia. Ibu hamil yang rajin memeriksakan kehamilannya mempunyai peluang besar untuk melahirkan bayi yang sehat dengan berat badan lahir normal. Apabila di dalam semua tahapan siklus hidup selanjutnya, bayi ini mendapatkan intervensi dan pelayanan kesehatan sesuai standar, maka dampaknya sangat besar terhadap pencapaian lanjut usia yang sehat, mandiri, aktif dan produktif

Penanganan terhadap pasien lansia dengan permasalahan kompleks sangat memerlukan support dari tim medis geriatri terpadu. Tim medis geriatri terpadu RS Prima Husada terdiri dari dokter spesialis interdisipliner yang meliputi internis, psikiater, dokter gigi, ahli gizi, apoteker, perawat, serta dokter spesialis dan terapis rehabilitasi medik. Berorientasi pada pasien, melalui penyusunan program pengobatan dan pemeliharaan kesehatan yang rasional, tim terpadu geriatri RS Prima Husada melakukan pendekatan asesmen geriatri secara menyeluruh. Melalui pendekatan asesmen geriatri yang terarah dan terpola, maka kemungkinan terjadinya miss diagnosis (kesalahan diagnosis) terhadap pasien dapat dihindari. Sehubungan dengan itu rumah sakit perlu menyelenggarakan pelayanan geriatri sesuai dengan tingkat jenis pelayanan geriatri tingkat sederhana

1.2 Tujuan

Tujuan umum

Meningkatkan mutu layanan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lanjut usia melalui Program Geiatri di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, yang dilaksanakan oleh semua departemen/unit di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Tujuan Khusus

1. Sebagai pedoman bagi direktur rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam membentuk organisasi, menyusun serta melaksanakan tugas, program, wewenang, dan tanggung jawab secara jelas.
2. Menggerakkan segala sumber daya yang ada di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan Program Geriatri.
3. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan keluarga, masyarakat dan lanjut usia dalam upaya peningkatan kesehatan lanjut usia
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Geriatri

1.3 Sasaran

Direktur, dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan lain di Rumah Sakit Prima Husada.

BAB II TATA LAKSANA

Kegiatan Tim GERIATRI di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya merupakan suatu standar mutu pelayanan dan penting bagi pasien, petugas kesehatan maupun pengunjung rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Pelayanan geriatri harus dilaksanakan oleh Tim GERIATRI rumah sakit dan juga fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk melindungi pasien, petugas kesehatan dari kejadian tindakan yang telah dilakukan kepada pasien, yang berbasis patient safety.

Kriteria pendukung:

1. Adanya pedoman kerja tentang Pelayanan GERIATRI di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi tujuan, sasaran, program, kebijakan, struktur dan anggaran organisasi, uraian tugas Tim GERIATRI.
2. Terdapat cakupan kegiatan tertulis mengenai program GERIATRI memuat tentang kebijakan dan pelayanan sesuai dengan standart yaitu :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan Geriatri
 - b. Pelayanan Rawat Inap Geriatri
 - c. Kunjungan Rumah (Home Care)
3. Kebijakan dan prosedur pelayanan geriatric di evaluasi setiap 3 (tiga) tahun untuk disempurnakan.

Adapun persyaratan pelayanan geriatri terdiri dari :

1. Lokasi
Lokasi pelayanan geriatri harus berdekatan dengan ruang perawatan dan ruang rehabilitasi medik serta berdekatan dengan akses masuk rumah sakit.
2. Bangunan
Bangunan pelayanan geriatri harus memenuhi konstruksi bangunan yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, dan Kesehatan pasien geriatri. Bangunan pelayanan geriatri tingkat lengkap paling sedikit terdiri dari :
 - a. Ruang pendaftaran/ administrasi
 - b. Ruang tunggu
 - c. Ruang pemeriksaan
 - d. Ruang bangsal geriatric akut (Ruang Rawat Inap dan Ruang Fisioterapi)
 - e. Ruang tim terpadu geriatric
3. Peralatan
Peralatan pada pelayanan geriatric meliputi peralatan untuk pemeriksaan, terapi dan latihan. Jenis peralatan pelayanan geriatric tingkat lengkap terdiri dari :
 - a. Ruang Pemeriksaan
 - Tempat tidur pasien
 - 1 set alat pemeriksaan fisik
 - EKG
 - Light box
 - Timbangan berat badan dan pengukur tinggi badan
 - Instrumen penilaian kognitif, psikologi, psikiatri
 - b. Ruang rawat Inap
 - Tempat tidur pasien
 - Oksigen
 - Suction
 - Komod
 - Light box
 - EKG
 - Blue bag
 - Chair scale

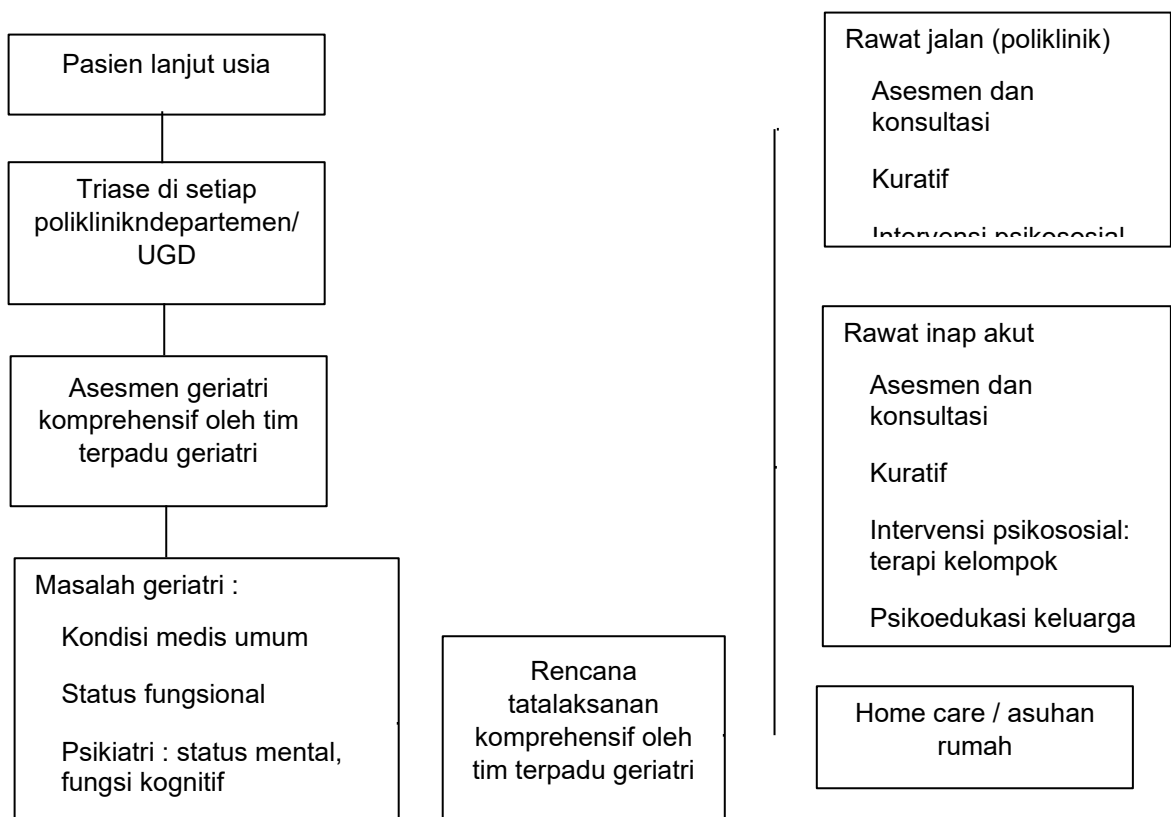
- Timbangan rumah tangga
- c. Ruang Fisioterapi
 - Paralel bar
 - Walker
 - Stick
 - Tripot
 - Quadripot
 - Kursi roda
 - Tilting table
 - Meja fisioterapi
 - Alat diatermi
 - TENS

4. Ketenagaan

Ketenagaan dalam pelayanan geriatri di Rumah Sakit terdiri atas tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan yang bekerja bersama-sama sebagai Tim Terpadu Geriatri. Tim terpadu geriatric pada pelayanan geriatri tingkat sempurna paling sedikit terdiri dari :

- a. Dokter spesialis penyakit dalam
- b. Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi
- c. Dokter spesialis kedokteran jiwa/ psikiater
- d. Dokter spesialis lainnya sesuai dengan jenis penyakit pasien geriatric
- e. Dokter
- f. Perawat yang telah mengikuti pelatihan keperawatan gerontic atau pelatihan keterampilan intiligensia
- g. Apoteker
- h. Tenaga gizi
- i. Fisioterapis
- j. Okupasi terapis
- k. Psikolog
- l. Pekerja social

Alur Pelayanan dan di Rumah Sakit dengan Pelayanan Geriatri Tingkat Lengkap :



BAB III

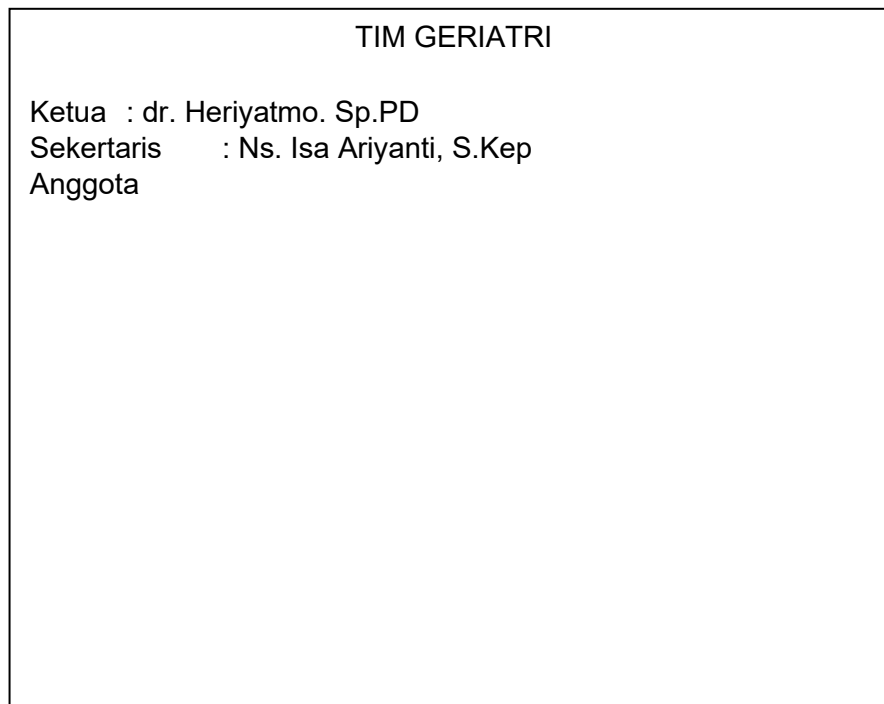
ORGANISASI TIM TERPADU GERIATRI

Organisasi Geriatri disusun agar dapat mencapai visi, misi, dan tujuan dari penyelenggaraan Geriatri. Geriatri dibentuk berdasarkan kadah organisasi yang miskin struktur dan kaya fungsi dan dapat menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara efektif dan efisien. Efektif dimaksud agar sumber daya yang ada di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dapat dimanfaatkan secara optimal.

3.1 Pimpinan dan Staf

Bagan Organisasi Tim Terpadu Geriatri Rumah Sakit Prima Husada

Tim Terpadu Geriatri di Rumah Sakit Prima Husada diketuai oleh seorang dokter dengan sekretaris seorang perawat. Berikut adalah merupakan bagan dari Tim Terpadu Geriatri Rumah Sakit Prima Husada.



TIM GERIATRI

A. Kriteria Anggota Tim GERIATRI

1. Mempunyai minat dalam GERIATRI
2. Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan GERIATRI

B. Uraian Tugas

Tim GERIATRI mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sebagai motor penggerak penyusunan program GERIATRI rumah sakit;
2. Melakukan monitoring dan memandu penerapan program GERIATRI di unit kerja;
3. Menjalani komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait serta menyampaikan masalah terkait pelaksanaan program GERIATRI;
4. Terlibat secara penuh dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan GERIATRI;
5. Bertanggung jawab untuk mengomunikasikan masalah-masalah GERIATRI secara rutin kepada ketua GERIATRI dan direktur Rumah Sakit;
6. Menyusun regulasi terkait penerapan program GERIATRI.

Tugas masing-masing unit adalah sebagai berikut :

1. Ketua Tim Terpadu Geriatri

1) Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan upaya pelayanan geriatri

sesuai dengan tingkatan pelayanan.

- 2) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerjasama lintas program dan lintas sektoral dengan berbagai disiplin.

2) Uraian Tugas :

- 1) Merencanakan/membuat rencana kerja kebutuhan tim geriatri setiap tahunnya.
- 2) Menyelenggarakan pelayanan geriatri berdasarkan rencana kebutuhan ketenagaan, sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh direktur rumah sakit.
- 3) Menyelenggarakan rujukan, baik di dalam maupun ke dan dari luar rumah sakit.
- 4) Menyelenggarakan kerjasama dengan tim/departemen/ bagian/KSMF (Kelompok Staf Medik Fungsional) lain di rumah sakit, serta hubungan lintas program dan lintas sektoral melalui direktur rumah sakit.
- 5) Memberikan laporan berkala tim terpadu geriatri kepada Direktur Rumah Sakit.

3) Tanggung jawab

- 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan visi dan misi program Geriatri.
- 2) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan evaluasi.
- 3) Bertanggung jawab terhadap Direktur.

4) Wewenang

- 1) Mendelegasikan tugas apabila berhalangan hadir.
- 2) Memeriksa hasil kegiatan Tim Geriatri.

5) Syarat Jabatan

- 1) Pendidikan dasar dokter Spesialis Penyakit Dalam.
- 2) Pernah mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidangnya.
- 3) Memiliki dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi.
- 4) Memiliki kemampuan kepemimpinan.

2. Sekretaris Tim Terpadu Geriatri

1. Hasil Kerja

- 1) Terkelola dan terdokumentasinya seluruh data Kegiatan Program Geriatri.
- 2) Terkoordinasinya seluruh program kegiatan Geriatri.

2. Uraian Tugas

- 1) Membuat undangan rapat dan membuat notulen.
- 2) Mengelola administrasi surat-surat Tim Geriatri.
- 3) Mencatat data-data yang berhubungan dengan Tim Geriatri.
- 4) Mencatat data-data yang berhubungan dengan Tim Geriatri.
- 5) Memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan oleh penanggung jawab dan penanggung jawab sosialisasi dari suksesnya program Geriatri.
- 6) Melakukan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan Program Geriatri.

3. Anggota Tim Terpadu Geriatri

a. Hasil kerja

Terselenggaranya semua program Geriatri di Rumah Sakit

b. Uraian Tugas

- 1) Melaksanakan pelayanan program Geriatri.
- 2) Melakukan koordinasi dengan ketua Tim Geriatri dan tim medis lain.

c. Melaksanakan evaluasi terhadap kasus-kasus yang terkait dengan Geriatri

d. Tanggung Jawab

- 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program.
- 2) Bertanggung jawab kepada ketua Tim Geriatri

-
- e. Syarat Jabatan
 - a. Pendidikan DIII/Sederajat
 - b. Memiliki ketrampilan dan pengetahuan tentang Program Geriatri Rumah Sakit
 - c. telah mengikuti pelatihan keperawatan gerontik atau pelatihan keterampilan

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

4.1 Monitoring

1. Monitoring dilakukan anggota Tim Terpadu Geriatri.

4.2 Evaluasi

1. Evaluasi oleh Tim Terpadu Geriatri minimal setiap 3 bulan.
2. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan guna mewujudkan keberhasilan program pelayanan kesehatan bagi pasien geriatri. Pemantauan dan evaluasi harus ditindaklanjuti untuk menentukan faktor-faktor yang potensial berpengaruh agar dapat diupayakan penyelesaian yang efektif. Pemantauan dan evaluasi mutu dilakukan dalam bentuk kegiatan pencatatan dan pelaporan. Diperlukan sejumlah indikator dalam pencatatan, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Lama rawat
Lama rawat pasien geriatri di ruang rawat inap akut tergantung dari kemampuan TTG serta dukungan sarana dan prasarana. Makin terampil dan lengkap, lama rawat akan semakin singkat. Rata-rata lama rawat pasien geriatri yang masuk karena mengalami geriatric giants dan dirawat inap dengan menerapkan pengkajian paripurna pasien geriatri adalah 12 hari.
 - b. Status fungsional
Status fungsional pasien diukur sejak pasien masuk rumah sakit sampai saat pemulangan. Diukur rata-rata kenaikan skor status fungsional pasien geriatri dengan karakteristik seperti diatas adalah 4/20 jika menggunakan instrumen ADL Barthel.
 - c. Kualitas hidup
Penilaian kualitas hidup harus menggunakan instrument yang mampu menilai kualitas hidup terkait Kesehatan (health related quality of life = HRQoL).
 - d. Rawat inap ulang (rehospitalisasi)
Rehospitalisasi adalah perawatan Kembali setelah pulang ke rumah dari rumah sakit. Perawatan yang terjadi kembali dalam 30 hari pertama pascarawat menggambarkan adanya permasalahan Kesehatan yang sesungguhnya belum optimal ditatalaksana di rumah sakit. Persentasi maksimal rehospitalisasi pasien geriatric pascarawat inap akut adalah 15%. Rehospitalisasi ini dapat dipengaruhi oleh kesiapan tim terpadu geriatric serta dukungan yang ada di rumah sakit. Rehospitalisasi juga tak terlepas dari pengaruh kemampuan puskesmas dan community based geriatric service.
 - e. Kepuasan pasien
Kepuasan pasien diukur saat pasien pulang dengan instrument yang secara sah dapat mengukur kepuasan pasien. Salah satu instrument yang sering digunakan adalah Patient's Satisfaction Questionair (PSQ). Instrument ini memiliki nilai standar minimal 190.

4.3 Laporan

Membuat laporan tertulis kepada Direktur setiap 3 bulan dalam bentuk laporan triwulan. Laporan ditandatangani oleh Ketua Tim Terpadu Geriatri.

Ditetapkan di Malang

Pada Tanggal 09 Juni 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah